

02 - 03- Les Troubles Phobiques - Pr. Laffinti

(0:01 - 0:28)

On passe au deuxième chapitre, toujours dans le même chapitre des troubles anxieux. On va traiter d'autres troubles anxieux qui sont les troubles phobiques. Les troubles phobiques s'agroupent en trois types de phobies qui sont tous considérés comme des troubles anxieux.

(0:29 - 1:20)

Dans ce chapitre, il y a des troubles phobiques. La phobie, ça se définit comme, c'est une peur, c'est une crainte que vous reconnaissez, la phobie, la phobia, donc c'est une crainte anxieuse qui est pathologique du fait qu'elle est disproportionnée, qui est souvent déclenchée soit par un objet ou soit par une situation dont le caractère n'est pas réellement dangereux. Donc ça définit le caractère pathologique parce que c'est une peur qui est disproportionnée par rapport à l'objet ou la situation, qui la génère.

(1:22 - 1:54)

Donc c'est une peur qui va se déclencher de façon systématique chaque fois que l'objet ou la situation, chaque fois que la personne est exposée à l'objet ou la situation phobogène. C'est une peur que la personne n'arrive pas à contrôler, donc c'est une peur incontrôlable. Et que la personne va reconnaître comme étant quelque chose d'excessif, de disproportionné, mais qu'elle n'arrive pas à contrôler.

(1:55 - 2:35)

Et c'est une peur qui va être à l'origine chez cette personne de certaines conduites pour éviter d'être confrontée à la situation phobogène qu'on appelle des conduites contre-phobiques. Les troubles anxieux, les troubles phobiques, comme je viens de dire, ce sont des troubles anxieux qui ont trois types de troubles. L'agoraphobie, l'anxiété sociale, anciennement appelée phobie sociale, et les phobies spécifiques.

(2:42 - 3:28)

On va d'abord commencer par l'anxiété sociale ou la phobie sociale. Qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble anxieux qui se définit par la présence d'une peur excessive et durable, une peur très gênante qui est dans l'objet, et le mouvement et le regard de l'autre dans des situations d'interaction sociale. Il s'agit d'une crainte dans l'objet où la personne va craindre le regard, le jugement des personnes dans des situations sociales.

(3:28 - 4:17)

Il va craindre d'agir ou de se comporter de façon un peu embarrassante ou humiliante devant

l'autre. Ce regard ou le jugement de l'autre peut être réel dans des situations, par exemple, d'exposition, d'exposer, ou comme il peut être juste supposé par la personne alors que les autres ne s'intéressent même pas à son comportement. C'est un trouble aussi très, très fréquent, jusqu'à 12% dans la population générale à travers le monde, avec toujours une prédominance féminine, toujours de femme pour un homme.

(4:18 - 4:54)

C'est un trouble aussi qui expose à beaucoup de comorbidités anxieuses, dépressives, à l'utilisation abusive des substances, aux troubles addictifs. Sur le plan clinique, le début va commencer très tôt dans la vie, dès l'enfance, début de l'adolescence. On se retrouve à s'installer progressivement.

(4:55 - 6:02)

Généralement, chez des personnes qu'on décrit comme étant très timides, repliées, qui ont un certain tempérament anxieux, et qui vont, par la suite, au fil des années, les symptômes vont s'accroître petit à petit avec l'âge, du fait que la personne en grandissant va être exposée de plus en plus à des situations, elle est amenée à interagir avec des personnes nouvelles, dépendant de ses études, de son travail, des voyages. En grandissant, la personne va être plus en contact avec les gens, et les symptômes d'anxiété dans les situations sociales vont de plus en plus être évidents. Dans d'autres cas, le trouble peut se déclencher plus tardivement chez une personne adulte, souvent suite à un événement, à une situation où la personne a été humiliée, où son estime de cela a été vraiment ébranlée.

(6:02 - 6:43)

Ça peut être le début ou le temps de départ de l'installation du trouble. La forme typique d'anxiété sociale est caractérisée par cette pause excessive par rapport au danger de la situation sociale que la personne redoute. Le sujet sait que la situation n'est pas dangereuse, il sait que sa réaction est excessive par rapport à la réalité du danger de la situation, mais il n'arrive pas à contrôler son anxiété et son angoisse.

(6:44 - 7:37)

Cette confrontation à ces situations sociales va déclencher instantanément une réaction anxieuse, mais bien avant juste le fait de connaître que la personne va être exposée à cette situation redoutée, l'angoisse peut s'installer instantanément. Parfois, les signes de l'anxiété vont être tellement importants et correspondent à l'attaque de panique qu'on a décrit la dernière fois. Sur le plan clinique, cette anxiété va se traduire toujours sur les différents registres psychiques, physiques et comportementaux.

(7:37 - 8:14)

D'abord, sur le plan psychique, on va avoir des symptômes émotionnels et cognitifs. Sur le plan des émotions, la personne va ressentir une tension nerveuse avec un sentiment de malaise associé à une peur et aussi un sentiment de honte. Cette peur de quoi ? La peur de toute remarque, toutes les approbations qui peuvent émaner d'autrui constituent une véritable agression pour ces personnes.

(8:15 - 9:23)

Ils ont peur de recevoir ce genre de commentaires négatifs ou de critiques. La honte, pourquoi ? Parce que la personne est persuadée et convaincue que son comportement était non conforme aux règles du groupe et qu'il ne s'est pas comporté conformément, qu'il ne s'est pas comporté correctement et donc il va développer ce sentiment de honte et ce sentiment d'être dévalorisé ou diminué par les autres. Les deux émotions vont coexister chez la même personne, donc la peur va s'installer avant l'exposition à la situation sociale et va continuer tout au long de l'exposition de la personne à cette situation redoutée et la honte va débiter avec l'exposition à la situation sociale et peut continuer même après cette situation.

(9:23 - 9:56)

Après la situation, la personne va garder ce sentiment de honte de ne pas se comporter conformément. Sur le plan cognitif, dans le processus psychique qui se passe chez ces personnes, ils ont une certaine anxiété d'évaluation. Cette anxiété d'évaluation, ce sont des placés toujours négatifs par rapport au jugement des autres.

(9:57 - 10:28)

La personne est pratiquement toujours convaincue qu'elle va recevoir un jugement négatif de l'un pour l'autre, que les autres vont le rejeter. Ce jugement négatif et cette anxiété d'être toujours sous l'évaluation et le jugement de l'autre, ce sont des processus psychiques qui se passent dans la tête de ces personnes. Il y a aussi un trouble de l'estime de soi.

(10:28 - 10:58)

C'est des personnes qui ont une faible estime de soi, avec des idées d'autodépréciation, des idées d'autodévalorisation qui sont pratiquement constantes. Il y a aussi une certaine anxiété anticipatoire ou une anticipation plutôt négative. La personne va toujours avoir cette appréhension de son comportement avant même la situation d'exposition.

(10:58 - 11:33)

Elle va toujours avoir ces idées de je vais mal réagir, je ne saurais pas quoi dire, je tremble, je serais incapable, je ne vais pas pouvoir être à la hauteur. Il va toujours avoir ce genre d'idées d'anticipation négative sur son comportement vis-à-vis de la situation. Il y a aussi ce qu'on

appelle des rémunérations après coup, des rémunérations négatives même au-delà de l'exposition à la situation.

(11:34 - 12:03)

Même au-delà de l'exposition à la situation sociale, la personne va garder toujours ces rémunérations négatives. C'est-à-dire que les personnes étaient ennuyées, donc elles ont dû remarquer un malaise et elles ont vu que je transpirais ou que je tremblais ou que je suis devenu rouge. Donc elles vont garder ce genre de rémunération même après la situation sociale.

(12:04 - 12:39)

Et tout ça, bien sûr, va retentir sur le plan attentionnel et amnésique avec des troubles de l'attention, de l'aimement, parce que l'esprit, justement, est concentré sur autre chose, est focalisé sur autre chose. C'est justement cette attention focalisée sur soi qui est toujours un des processus cognitifs qui se passent. Donc la personne est tellement focalisée sur sa personne, sur ses symptômes, sur ses tremblements, sur sa transpiration.

(12:41 - 13:08)

Elle est en train d'anticiper l'interprétation des gens de ses symptômes. Donc elle est concentrée sur ses symptômes physiques et sur comment les autres, pour se faire une idée négative de comment les autres vont les interpréter et les voir. Cette hyperconcentration sur soi va se faire au détriment, bien sûr, de l'interaction, de la situation sociale elle-même.

(13:08 - 13:55)

Donc au lieu d'interagir entre lui et l'interlocuteur, la personne va être concentrée sur elle-même, bien sûr, et ça va porter atteinte à la qualité de l'interaction lors de la situation sociale. Donc ce qu'il craignait lorsque elle redoutait, il va tomber justement sur ce qu'il craignait. Sur le plan physique, c'est toujours les symptômes physiques de l'anxiété, avec comme particularité l'anxiété sociale, c'est surtout les transpirations, les yeux, le mal à la moitié des mains, les bouffées de chaleur.

(13:56 - 14:46)

C'est aussi les tremblements, que ce soit des pieds, des mains, des tremblements de la voix, le bégayement, aussi le rougissement des personnes qui deviennent rouges, qui bégayent. Avec d'autres symptômes comme la tension musculaire, la palpitation liée à l'hyperactivité neuro-égétative, qui au maximum dans des états plus avancés, extrêmes, peuvent traduire une véritable attaque de panique. Sur le plan comportemental, l'anxiété peut être à l'origine d'une certaine inhibition, mais souvent plutôt à une agitation plutôt désordonnée, une instabilité.

(14:47 - 15:04)

Mais surtout, ce qu'on voit chez ces personnes, c'est des évitements. Les évitements, c'est des comportements qui accompagnent presque toujours tout ce qui est phobie. Ce qui est phobie, qui dit peur, dit fuir l'objet de la peur.

(15:05 - 15:31)

La personne essaie d'éviter les sources de sa peur. Ces évitements sont quasi constants, ils sont récurrents. Ils peuvent être des évitements complets ou incomplets, mais ce sont des évitements qui vont favoriser la chronicité, la périodisation du trouble.

(15:33 - 15:55)

On décrit généralement deux types d'évitements, les évitements situationnels et les évitements dits subtils. Les évitements situationnels, ce sont des évitements complets. La personne va essayer de trouver le moyen pour éviter complètement d'être confrontée à la situation redoutée.

(15:55 - 16:46)

Elle va essayer de trouver des prétextes pour ne pas être confrontée. Par exemple, une personne qui devrait faire une présentation, un exposé, il va essayer de soumettre une pathologie pour être absente le jour de cette présentation et de cet exposé, donc ne pas participer. Une personne, par exemple, invitée à un mariage où il y a du mal à être observée par les personnes, va trouver un aménagement pour dire qu'il a un travail urgent à régler pour ne pas aller à cette invitation, à ce mariage, à cette soirée.

(16:47 - 17:45)

Donc c'est un évitement, on dit situationnel, un évitement complet. Pour d'autres personnes, pour la majorité, il y a des évitements, ce qu'on appelle subtils, c'est quand la personne ne peut pas éviter complètement la situation, donc elle est obligée de confronter cette situation, mais à ce moment-là, elle va essayer de trouver d'autres subtilités pour essayer de minimiser l'impact de la confrontation à cette situation sociale. Par exemple, une personne qui va aller, par exemple, à une conférence, elle va s'installer au fond de la salle pour être le plus loin des deux gens, ou elle va s'installer juste à côté de la porte pour pouvoir sortir et quitter la salle au moindre sentiment d'anxiété.

(17:47 - 18:37)

Aussi, par exemple, une personne invitée à un restaurant, par exemple, qui a un rendez-vous de travail dans un restaurant, elle va essayer, par exemple, d'arriver très tôt pour choisir un endroit le plus discret, le plus loin des autres tables, pour ne pas être sous le regard des autres. D'autres personnes vont, par exemple, essayer de porter des vêtements qui sont discrets pour ne pas attirer le regard des gens. Ce sont des subtilités que les personnes vont essayer de faire pour

éviter d'être confrontées à des situations entoutées.

(18:41 - 19:20)

Pour nous, ce type d'anxiété sociale, ça peut être une anxiété de type généralisée, donc ça englobe des situations redoutées qui peuvent être de plusieurs domaines. La personne craint plus de trois types de situations sociales. Ce sont souvent des formes qui débutent précocement, qui sont assez sévères, qui vont tenter négativement sur la personne, sur le plan social, professionnel et familial.

(19:22 - 20:03)

Il y a aussi ce type spécifique, généralement, quand l'anxiété sociale ne recrute qu'un seul type de situation, et c'est généralement dans ce cas les situations de performance où la personne doit montrer sa performance. Ce sont des formes, bien sûr, moins sévères, avec moins d'attentisme. Pour les types de situations ou de catégories de situations sociales décrites, ce sont, comme on vient de le dire, les situations de performance.

(20:03 - 20:23)

Ce sont les situations où la personne est réellement sous le jugement de dormir. Par exemple, la personne qui va passer un entretien d'embauche ou va faire un exposé, une présentation. Par exemple, le jour de la soutenance de texte.

(20:23 - 20:55)

Ce sont des situations de performance où la personne va s'exprimer en public devant tout le monde. C'est l'un des types de situations. Les situations d'observation, ce sont toutes situations où la personne va être persuadée ou l'impression d'être regardée par les gens alors qu'elle est en train d'accomplir une tâche quelconque.

(20:56 - 21:35)

Une personne qui est en train de manger, de boire, de conduire sa voiture ou de se garer. Les personnes qui ont cette anxiété sociale ont toujours cette impression que les gens les regardent alors qu'ils sont en train de manger ou en train de se garer et que les gens les regardent et les jugent négativement. Les situations d'affirmation, ce sont toutes les situations où la personne doit donner son opinion, son avis, exprimer son mécontentement, son désaccord, sa désapprobation.

(21:36 - 22:01)

Par exemple, un marchand doit négocier un prix. Ce sont aussi des situations où les personnes qui ont une anxiété sociale essayent d'éviter ou qui vivent avec beaucoup d'anxiété. Ça peut être exploité par exemple par les marchands, les gens qui n'arrivent pas à négocier ou à dire non.

(22:01 - 22:44)

Donc souvent les autres peuvent exploiter ce point de faiblesse chez ces gens-là. Donc les situations de révélation de soi, ce sont des situations où la personne doit exprimer quelque chose d'intime, de parler plus profondément de sa personne, comme les situations où la personne est amenée à nouer de nouvelles relations amicales, sentimentales ou autres. Et puis ça peut aussi être toute situation d'interaction sociale.

(22:44 - 23:08)

Donc toute situation où la personne va être amenée à entrer en interaction avec l'autre peut constituer une situation redoutée. C'est par exemple le fait de parler, de croiser un voisin dans un ascenseur. Donc pour certaines personnes, même ces situations peuvent être très gênantes.

(23:08 - 23:43)

Ou de parler avec le passager à côté, ou de parler à quelqu'un dans une salle d'attente. Donc toutes ces situations d'interaction qui n'engagent pas vraiment la personne, mais qui peuvent être aussi sources d'anxiété et d'angoisse pour ces gens-là. Par exemple, où une personne qui, pendant un voyage dans un cas pertinent, peut se retrouver avec un passager dans un train.

(23:44 - 24:08)

Donc ces situations peuvent être assez gênantes pour ces personnes. Par exemple, ils peuvent faire semblant de fermer les yeux ou de dormir pour éviter de communiquer, d'entrer en interaction avec les gens du même comportement. Donc c'est aussi une sorte d'évitement subtil.

(24:09 - 24:35)

Donc la personne essaie de trouver des stratégies pour éviter la situation. Les diagnostics positifs sortent du critère du DSM. Donc il y a plusieurs critères.

(24:35 - 24:51)

Le critère, c'est cette peur à l'anxiété dans plusieurs situations sociales. Le deuxième critère, c'est que la personne craint agir et démontrer les symptômes d'anxiété. Elle craint d'être jugée négativement.

(24:51 - 25:19)

Donc le troisième critère, c'est que les situations sociales sont créées toujours par cette anxiété. Le quatrième, c'est que les situations vont être à l'origine de ce comportement d'évitement, ou sinon elles vont être subies avec une anxiété intense. Et cette anxiété, bien sûr, elle est disproportionnée par rapport à la menace réelle de la situation.

(25:20 - 25:41)

Un autre critère important, c'est le critère de durée. Donc il faut que cette anxiété, cette peur, ces évitements dépassent les six mois. Donc on ne veut pas porter le diagnostic chez une personne qui a montré l'ensemble de ses symptômes sur une situation ou deux situations pendant une courte durée.

(25:42 - 25:49)

Donc on ne peut pas porter le diagnostic d'anxiété sociale. C'est un problème qui s'inscrit dans la durée. Au minimum, six mois.

(25:53 - 26:03)

Les autres critères, c'est des critères plutôt de délimitation. Donc c'est des critères qui reviennent. Il ne faut pas que ce soit lié à d'autres pathologies.

(26:08 - 26:56)

Pour le diagnostic différentiel, il se fait d'abord par ce qu'on peut appeler anxiété sociale, j'allais dire normale. Donc dans des situations où on peut tous avoir un certain trac, un certain stress quand on est amené, par exemple, à parler en public ou à rencontrer des gens d'un certain niveau hiérarchique ou quand on est amené à être reçu par des autorités, on peut avoir un sentiment d'anxiété, de trac, mais ça reste assez léger, ça reste contrôlable, ça reste passager et ça ne se répète pas. Donc le diagnostic différentiel se fait aussi avec les autres troubles.

(26:56 - 27:24)

Donc le trouble panique, on avait l'anxiété anticipatoire, c'est par rapport à la survenue d'attaques de panique et pas par rapport aux situations sociales. L'anxiété généralisée, l'anxiété qu'on vient de voir, c'est lié à des soucis qui n'ont pas vraiment lien avec l'interaction en situation sociale. Pour l'agoraphobie, on va la traiter tout de suite, ainsi que les phobies spécifiques.

(27:26 - 27:56)

Pour les troubles obsessionnels compulsifs et apparentés, surtout pour les obsessions impulsives, où la personne va craindre le fait de se comporter ou de faire un acte absurde contre sa volonté en plein public. Mais c'est à la différence de l'anxiété sociale. C'est une idée que la personne va avoir dans son esprit indépendamment de l'exposition en situation sociale.

(27:56 - 29:02)

C'est des idées intrusives qui s'imposent à l'esprit de la personne obsessionnelle qui va se dire qu'il n'a pas le droit de se comporter de façon absurde, émulative, ou de faire un geste déplacé au plein public. Pour les troubles dépressifs que vous avez traités, on peut aussi trouver comme

symptôme lié à la dépression, ce retrait social, cette clonophilie, cette tendance à l'isolement liée à la dépression. Mais à la différence de l'anxiété sociale, on va trouver des symptômes dépressifs qui vont guider le diagnostic et orienter le diagnostic.

(29:06 - 29:38)

À la différence aussi de certains troubles de la personnalité, notamment la personnalité schizoïde. La personnalité schizoïde, c'est une personnalité qui est caractérisée par une certaine indifférence par rapport à l'interaction de relations amicales, sociales, familiales. C'est une personnalité qui vit dans son propre monde avec restriction de toute relation à autrui et qui n'est pas forcément liée à une anxiété d'être jugée.

(29:38 - 30:17)

Au contraire, c'est une personne qui est généralement indifférente aux allégo-critiques. C'est une personnalité psychotique qui ressemble à un degré moindre de la schizophrénie. Pour la personnalité invitante, c'est plutôt un trouble très souvent comorbide à l'anxiété sociale parce qu'elle est aussi caractérisée par cette autodévalorisation, cette perception de soi comme inférieure sur le plan social.

(30:18 - 30:35)

C'est aussi une personnalité qui redoute les situations sociales. C'est un mode de fonctionnement un peu plus profond et on peut dire que c'est la forme plus sévère de l'anxiété sociale. Souvent, ce sont des événements comorbides.

(30:39 - 31:10)

Sur le plan étiopathogénique, il y a toujours l'influence de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs génétiques qui exposent au développement du trouble, aussi des facteurs neurobiologiques, notamment un dérèglement de la neurotransmission. Cette hypothèse est éteinte par l'effet positif des antidépresseurs.

(31:11 - 32:01)

Il y a aussi une application de certaines structures cérébrales démontrée dans l'imagerie fonctionnelle, certaines régions cérébrales qui seraient plus hyperactives chez ces personnes. Pour les facteurs psychologiques, l'ambiance sous-temperament un peu anxieux, cette hyper-émotivité, cette inhibition dès la petite enfance, cette faible estime de soi, un manque de confiance, et aussi le perfectionnisme des gens qui essaient d'être parfaits. Il y a toujours ce risque de développer ce genre de trouble.

(32:03 - 33:08)

Il y a aussi les facteurs éducatifs liés aux maltraitances répétées pendant l'enfance, aux châtements et dénigrements répétés pendant l'enfance, les parents, les enseignants qui traitent l'enfant de moins que rien, d'incompétents, ce genre de dénigrement répété peut tenter le développement psychologique de l'enfant et faire lier le développement de troubles psychiques, en l'occurrence une anxiété sociale. Mais il y a aussi le cas contraire, un environnement hyper protecteur qui essaie de protéger l'enfant à tout prix du monde extérieur, qui ne laisse pas explorer le monde extérieur. Cet enfant va toujours avoir peur de tout ce qui est interaction avec le monde extérieur.

(33:09 - 33:44)

Et puis également, certains secteurs avancent le modèle de l'apprentissage social. Quand on a un parent, un père ou une mère qui est phénique sociale, l'enfant, par imitation, peut s'attribuer des symptômes d'anxiété sociale. D'autres modèles psychologiques, surtout quand on a eu cette conscience excessive de soi, cette focalisation sur ses propres réactions, détruiront les interactions.

(33:45 - 34:22)

Et tout dernièrement, les évitements qu'on a vu, qui sont un facteur important et très aggravant, et un facteur de maintien du trouble, qui va contribuer au maintien et à la pérennisation du trouble. Donc la personne, en évitant de se confronter à la situation ou à l'objet phallogène, va avoir l'impression qu'il a bel et bien évité un danger réel. Et ça contribue à recréer dans son esprit le fait que vraiment cette situation est d'un certain danger, et donc qu'il faut éviter.

(34:29 - 34:53)

L'évolution du trouble sans traitement va se faire de façon chronique, sur plusieurs années. On peut, après plusieurs années, voir une atténuation du trouble, après 20 ans. Mais sous un traitement bien conduit, les résultats sont généralement assez intéressants.

(34:54 - 35:28)

Pour les complications, bien sûr, on peut imaginer que des personnes qui souffrent d'un tel trouble, avec tout le retentissement social, peuvent venir par décompenser, par développer une dépression. Ou pour d'autres, c'est le recours à des substances qui vont atténuer l'anxiété, atténuer la souffrance liée à l'exposition, comme l'alcool, les drogues ou les tranquillisants. L'handicap social est assez fréquent.

(35:29 - 36:14)

Des gens qui vont, par exemple, arrêter leurs études parce qu'ils ont du mal à être confrontés aux groupes d'autres gens qui ne veulent pas évoluer dans leur carrière, parce que pour éviter,

par exemple, des postes, il est amené à interagir le plus avec des gens, donc il va renoncer à cette évolution. Donc l'handicap social et professionnel peuvent se voir aussi avec le trouble d'anxiété sociale. Pour la prise en charge du trouble, à voler psychothérapeutique et médicamenteux, nos psychothérapies préconisées sont les psychothérapies cognitives et comportementales.

(36:15 - 36:38)

Les résultats sont validés, c'est assez intéressant. C'est une approche, bien sûr, qui implique à la fois le thérapeute et aussi en collaboration avec le patient lui-même. C'est des séances qui peuvent s'organiser dans un groupe de 3, 4 ou 5 personnes.

(36:40 - 37:22)

Pendant les séances, il y a plusieurs techniques. Il y a le traitement aux habilités sociales qui vont aider la personne à améliorer ses qualités communicationnelles et surmonter ses difficultés d'interagir à travers des concerts, à travers aussi des jeux de rôle où patients et thérapeutes peuvent jouer le rôle de situation sociale ou dans le cadre d'un petit groupe qui ont le même trouble, ça peut aussi être intéressant de travailler des jeux de rôle. On utilise aussi des techniques d'exposition.

(37:22 - 37:49)

L'exposition est assez utilisée dans le domaine des phobies. On essaie d'exposer de façon progressive et graduelle la personne aux situations redoutées tout en l'aidant à gérer son anxiété, son angoisse au fil des expositions. L'anxiété va finir par s'atténuer.

(37:51 - 38:18)

Les techniques cognitives essaient d'identifier les schémas rationnels de pensée et de les corriger. Pour le traitement médicamenteux, le traitement que nous ferons toujours, ce sont les oxydatresseurs. En première intervention, toujours inhibiteurs sélectifs pour la capture de la sérotonine mais aussi les IRSN1.

(38:20 - 38:58)

Généralement, c'est un traitement qui est préconisé pour les femmes sévères. Ce qui est préférable, c'est associer à la fois le traitement médicamenteux et le traitement psychothérapeutique qui donnent des résultats beaucoup plus intéressants. Bien sûr, avec la difficulté, l'inaccessibilité des TCC, le traitement médicamenteux reste l'alternative la plus utilisée et la plus utilisée par les thérapeutes.

(39:01 - 40:06)

Pour les règles de prescription, toujours une introduction progressive avec un vaccin assez long, de 6 à 8 semaines, et une durée totale du traitement qui peut aller jusqu'à 12 mois, voire plus, 12 mois après une réponse satisfaisante. Pour le traitement d'antidépresseurs à chaque fois, il faut bien sûr surveiller les effets secondaires, la tolérance pour un arrêt, c'est préférable que ce soit un arrêt progressif. Pour d'autres médicaments, les benzodiazépines n'ont pas vraiment d'indication pour l'aphobie ou l'anxiété sociale elle-même, mais ça peut être un traitement portuel si on est devant face à une anxiété importante qui débouche sur une attaque dépanique, ça peut être un traitement ponctuel par les benzodiazépines.

(40:08 - 40:38)

Et notre monocule, ce sont les beta-bloquants. Donc les beta-bloquants peuvent aussi être intéressants, surtout pour ce qui est de l'anxiété dans une situation de performance où la personne va être exposée à une situation sociale de performance. Donc ça permet d'atténuer les symptômes neurovégétatifs, la tachycardie et surtout la tachycardie.

(40:39 - 41:04)

Donc ça peut être une prise une heure avant la situation de performance qui peut aider la personne. Mais ce n'est pas un traitement continu, c'est juste un traitement ponctuel en prévention de l'exposition à la situation de performance. Donc voilà pour l'anxiété sociale.

(41:05 - 41:27)

S'il n'y a pas de questions, on passe à l'agoraphobie. Donc deuxième trouble phobique, c'est l'agoraphobie. L'agoraphobie est un autre trouble anxieux qui est caractérisé par, là aussi une peur, qui dit phobie, dit une peur.

(41:28 - 42:05)

Qui est durable aussi. Et cette peur, elle est au rapport avec le fait de se retrouver dans une situation où il pourrait être difficile de s'échapper ou de trouver du secours au cas de survenir à l'attaque de panique ou d'autres symptômes. Donc la personne, bien sûr, va soit éviter ces situations ou être accompagnée par la présence d'une autre personne ou sinon elle va subir ces situations avec une grande souffrance.

(42:12 - 42:47)

Je ne sais pas si la définition est assez claire. Donc le fait, c'est une peur que la personne va avoir de se retrouver dans des situations où il y aura du mal et elle aura du mal à échapper ou à trouver de l'aide si jamais elle présente des symptômes graves ou une attaque de panique. Donc si vous rappelez, ça ressemble à l'anxiété anticipatoire de du trouble de panique.

(42:47 - 43:10)

Donc l'anxiété anticipatoire qui soulève les attaques de panique. Donc ça ressemble un peu à ça. Et si vous vous rappelez, dans le cours du trouble de panique, j'avais dit que ces deux troubles étaient assez liés et que les symptômes peuvent, s'ils durent et s'organisent au-delà de six mois, peuvent constituer un autre trouble qui est l'agoraphobie.

(43:13 - 43:32)

Les situations qui peuvent être agoraphobogènes sont sources de cette peur. Donc dans plusieurs situations, ça peut être les transports en commun, les bus, les métros, les autocars. Ça peut être aussi des endroits ouverts comme le parking.

(43:33 - 44:16)

Ça peut être aussi des endroits plutôt fermés comme les amphithéâtres, les salles de cinéma, les mosquées. Ça peut être aussi tout ce qui est fil d'attente où il foule, comme les petits ruelles de l'ancien Médina où il y a beaucoup de monde, où il y a une foule importante. Donc tous ces endroits-là peuvent être des situations que la personne craigne parce que pour elle, quand elle se retrouve dans ces endroits-là, si jamais elle développe une attaque de panique ou des symptômes importants, donc elle risque de ne pas pouvoir s'échapper ou trouver de l'aide.

(44:17 - 45:04)

Dans les cas extrêmes, ça peut être tout simplement le fait de se retrouver à l'extérieur de chez lui peut être déjà une situation agoraphobogène dans les cas les plus graves. Sur le point épidémiologique, c'est une prédominance féminine avec une incidence annuelle aux alentours de 2 %, donc un trouble qui généralement s'installe en fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Certains facteurs de risque, surtout génétiques et environnementaux, donc une comorbidité fréquente, comme je viens de le dire, avec le trouble de panique.

(45:07 - 45:35)

Par contre, le diagnostic positif, c'est la présence. C'est un diagnostic clinique, bien sûr, donc c'est cette peur exagérée et distensionnée de ne pouvoir s'échapper ou d'être secouru au moins dans des situations qu'on vient de décrire. Cette peur va entraîner, bien sûr, le comportement d'évitement ou être à l'origine d'une altération du fonctionnement.

(45:35 - 46:02)

Et surtout le critère de durée de 6 mois, qui est un critère très important et qui va différencier l'agoraphobie, par exemple, du trouble de panique. Pour le diagnostic différentiel, donc l'agoraphobie spécifique du type situationnel, on va le voir. Pour l'anxiété sociale, on a vu que c'est en rapport avec des situations sociales, des expositions sociales.

(46:03 - 46:17)

Là, c'est la peur de développer une attalibité de panique et de ne pas pouvoir s'échapper. Pour le trouble de panique, c'est surtout le critère de durée. Donc le trouble de panique, c'est des attalibés de panique et d'anxiété anticipatoire.

(46:18 - 46:55)

Mais si l'anxiété anticipatoire dépasse les 6 mois, on va faire le diagnostic d'une agoraphobie associée au trouble de panique. Pour le stress post-traumatique, il peut y avoir chez les personnes qui ont subi un traumatisme psychique grave comme on vient de le vivre avec le séisme. Les personnes vont avoir peur de sortir de chez elles ou de passer par certains endroits qui rappellent le traumatisme.

(46:57 - 47:42)

Pour le trouble dépressif, c'est surtout par rapport à l'anxiété sociale qui est souvent dans la dépression mais qui est souvent associée au tableau dépressif évident. L'évolution du trouble d'agoraphobie, c'est un trouble qui est assez persistant, assez chronique, mais dont les rémissions peuvent se sauver à long terme, notamment si le trouble est pris en charge correctement. Mais les rechutes sont assez fréquentes et pour les complications, c'est toujours des complications dépressives, l'usage abusif de substances.

(47:43 - 49:07)

Et dans les formes extrêmes de l'agoraphobie, c'est des personnes qui n'arrivent plus à sortir de chez eux et qui restent complètement indépendants de leur entourage et ça risque de retortir sévèrement sur leur qualité de vie. Maintenant, de l'agoraphobie, c'est l'association psychothérapie et pharmacothérapie, donc thérapie cognitive et comportementale qui sont privilégiées à première intention et qui vont faire appel aux techniques d'exposition, donc une exposition bien sûr graduelle, co-opressive aux situations agoraphobogènes qui vont, au fil des expositions, faire atténuer l'anxiété et faire une extinction de l'anxiété. On peut procéder par une exposition in vivo dans des situations réelles, comme on peut utiliser des techniques d'exposition imaginaire avec le thérapeute ou utiliser des techniques d'une réalité virtuelle où la personne va utiliser des casques et imaginer des situations agoraphobogènes avec l'aide du thérapeute qui va l'aider à bien gérer l'anxiété gérée par l'exposition à ces situations.

(49:10 - 49:27)

Le traitement médicalementaux de France, ce sont les antidépresseurs avec les mêmes règles de prescription, les mêmes molécules. La durée du traitement va de 6 à 12 mois. Pour les anxiolithiques, leur place est très limitée.

(49:27 - 50:08)

Ça peut aider à gérer une anxiété aiguë si la situation d'exposition déclenche par exemple une attaque de panique. On passe au dernier chapitre qui est les phobies spécifiques. Les phobies spécifiques sont des troubles dont la peur est déclenchée soit par un animal, soit par un objet ou par certaines situations particulières qu'on va voir et qui sont appelées objets au stimulus phobogène.

(50:08 - 50:36)

Ce sont des peurs disproportionnées, intenses, déclenchées à chaque fois avec l'exposition à l'objet, à l'animal ou à la situation phobogène. Ils sont très fréquents, aux alentours de 11 %, diagnostiques assez faciles. Ce sont des troubles qui n'attirent pas vraiment beaucoup de retentissement sur le plan social ou socio-professionnel.

(50:39 - 51:10)

Ce sont des gens qui demandent rarement les soins ou la thérapie. Leur caractère ici, ce sont des peurs qui débutent dès l'enfance mais sont indifférenciées des peurs un peu intenses que l'enfant peut avoir lors de son développement normal et qui généralement disparaissent à l'âge adulte. Là, ce sont des peurs qui vont persister jusqu'à l'âge adulte.

(51:12 - 51:35)

Souvent, les personnes ont une peur de plusieurs situations à la fois. Bien sûr, c'est en question du caractère disproportionné, du caractère de l'envie de l'autre. Le comportement qui va avec cette peur, c'est toujours ce comportement d'évitement ou d'échappement dont la situation ou l'objet va bouger.

(51:37 - 51:47)

Plusieurs catégories, plusieurs éléments qui peuvent être sources de phobies. Les plus fréquents sont les phobies d'animaux, les zoophobies. Ce sont les plus fréquents.

(51:48 - 52:03)

Ça touche 70 à 90 % des femmes. C'est un trouble qui touche majoritairement les femmes. Cette peur d'animaux peut être liée, peut être aperçue par le mouvement rapide de l'animal.

(52:04 - 52:14)

Pour d'autres, c'est surtout son apparence physique. Pour d'autres, c'est ses plumes, ses poils. C'est surtout le contact, le toucher.

(52:16 - 52:42)

Il y a plusieurs types de phobies, surtout les phobies des insectes, des abeilles, des araignées,

des cafards, les phobies des souris, des chats, des chiens. Il y a autant de phobies que d'objets animaux. Il y a aussi les phobies spécifiques liées aux événements naturels.

(52:43 - 53:02)

Certains ont peur de certains événements naturels comme les orages, le tonnerre, la pluie. D'autres ont peur des hauteurs, on parle d'acrophobie. Certains ont peur de l'eau, de l'obscurité.

(53:04 - 53:19)

Pour d'autres, c'est un climat nuageux. Ce sont des phobies spécifiques à un événement ou à un objet. Il y a aussi les phobies liées au sang.

(53:19 - 53:53)

Certains ont peur du regard du sang, peur des injections, peur des interventions, peur des soins dentaires. Ce sont des gens qui ont peur du sang. Contrairement à la plupart des phobies qui déclenchent une réaction anxieuse, c'est plus souvent une bradycardie avec risque de syncope et de perte de connaissance.

(53:55 - 54:36)

Les risques liés à ces phobies de sang, c'est que les gens qui ont ce genre de phobie vont éviter tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est examen, tout ce qui est bilan, tout ce qui est injection, voire éviter certaines opérations qui sont des fois obligatoires. Et plus dernièrement, les phobies de type situationnel, ce n'est pas les situations sociales, ce n'est pas les situations agoraphobogènes qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt le fait de se retrouver dans des situations très particulières. C'est le fait de se retrouver dans un ascenseur, ou le fait de se retrouver à bord du train.

(54:39 - 55:06)

Pas tout l'espace pour la commune, mais plutôt le fait de se retrouver dans le train ou dans l'avion. C'est à différencier des situations agoraphobogènes. Pour le traitement, c'est basé essentiellement sur la thérapie cognitive et comportementale pour les femmes assez sévères, avec des techniques d'exposition qui vont créer une habitude progressive.

(55:08 - 55:55)

Si on se confronte de plus en plus à l'objet phobogène, on va finir par atténuer l'anxiété et faire disparaître complètement l'anxiété. En ce qui est des médicaments, il n'y a pas de traitement spécifique, donc pas d'antidépresseur pour les phobies simples ou phobies spécifiques. Les benzodiazépines ont une place très limitée, donc on peut être devant une situation d'angoisse forte, on peut amener à prescrire ponctuellement une benzo, mais il faut garder à l'esprit que le

traitement pharmacologique n'est pas préconisé pour les phobies spécifiques.

(55:59 - 56:32)

Voilà pour le traitement de l'étrouplique. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on se dit à la prochaine.